TÓM TẮT ĐẠT MỨC 5 – TIÊU CHÍ C6.2

"Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp"

Để đạt **mức 5**, bệnh viện phải chứng minh được:
✅ Điều dưỡng thực hiện tư vấn – giáo dục sức khỏe đầy đủ, liên tục và cá thể hóa
✅ Người bệnh hiểu, hợp tác và tham gia chăm sóc
✅ Có tài liệu – quy trình – giám sát – đánh giá hiệu quả
✅ Hoạt động GDSK được số hóa, chuẩn hóa và cải tiến liên tục

1. HỆ THỐNG VĂN BẢN – QUY ĐỊNH ĐẦY ĐỦ

Bắt buộc phải có:
✅ Quy định giáo dục sức khỏe (GDSK)
✅ SOP tư vấn – hướng dẫn NB
✅ Quy định ghi nhận GDSK trong hồ sơ
✅ Phân công trách nhiệm điều dưỡng

Có biểu mẫu:

- Phiếu tư vấn GDSK
- Checklist hướng dẫn NB
- Phiếu đánh giá hiểu biết NB

2. NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỰC TẾ

Điều dưỡng phải thực hiện:

Khi nhập viện

- Nội quy khoa
- Quyền và nghĩa vụ NB
- Phòng ngừa té ngã
- Cách gọi hỗ trợ

Trong điều trị

- Dùng thuốc
- Dinh dưỡng
- Vận động
- Chăm sóc bệnh lý
- Phòng biến chứng

Khi ra viện

- Dùng thuốc tại nhà
- Tái khám
- Dấu hiệu nguy hiểm
- Chế độ sinh hoạt

3. GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHẢI CÁ THỂ HÓA

Mức 5 yêu cầu:
Không tư vấn "chung chung".
Phải phù hợp:

✅ bệnh lý
✅ độ tuổi
✅ trình độ nhận thức
✅ nguy cơ NB
✅ khả năng tự chăm sóc

Ví dụ:

Đối tượng	Nội dung ưu tiên
ĐTĐ	Tiêm insulin/chế độ ăn
COPD	Tập thở
Sau mổ	Vận động sớm
Người già	Phòng té ngã

4. CÓ TÀI LIỆU GDSK ĐA DẠNG

Nên có:

✅ Poster
✅ Tờ rơi
✅ Video
✅ TV truyền thông
✅ Mã QR hướng dẫn
✅ App/HIS hỗ trợ

Điểm cộng mức 5:

- Video theo bệnh lý
- GDSK điện tử
- Tài liệu song ngữ
- Hình ảnh trực quan dễ hiểu

5. CÓ GHI NHẬN TRONG HỒ SƠ CHĂM SÓC

Đoàn thường kiểm tra:

- Điều dưỡng có ghi GDSK không?
- Có lượng giá hiểu biết NB không?

Hồ sơ cần có:

✅ nội dung tư vấn
✅ thời gian
✅ người thực hiện
✅ phản hồi NB
✅ đánh giá sau hướng dẫn

6. GIÁM SÁT – AUDIT – KPI

Muốn mức 5 phải có:

Audit định kỳ ≥12 tháng

- hồ sơ GDSK
- thực hành tư vấn
- khảo sát NB

KPI ví dụ:

Chỉ số	Mục tiêu

NB được GDSK	≥95%
NB hiểu hướng dẫn	≥90%
NB hài lòng	≥90%
GDSK ghi hồ sơ đầy đủ	≥95%

7. NGƯỜI BỆNH THỰC SỰ HIỂU

Đoàn khảo sát thường hỏi NB:

- Điều dưỡng có hướng dẫn không?
- Có biết dùng thuốc không?
- Có biết khi nào tái khám không?
- Có hiểu dấu hiệu nguy hiểm không?

Muốn mức 5:

NB phải trả lời được thực tế.

8. CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Cần có:

✅ khảo sát hài lòng
✅ phân tích phản hồi NB
✅ cải tiến tài liệu GDSK
✅ cập nhật phương pháp truyền thông

Ví dụ:

Vấn đề	Cải tiến
NB không nhớ hướng dẫn	Video QR
Người già khó đọc	Tăng font/hình ảnh
Quá tải điều dưỡng	TV giáo dục tự động

9. ỨNG DỤNG CNTT (ĐIỂM CỘNG MỨC 5)

Nên có:

- GDSK trên HIS
- Video tại buồng bệnh
- QR code hướng dẫn
- SMS/Zalo nhắc tái khám
- Dashboard theo dõi GDSK

10. MINH CHỨNG "ĂN ĐIỂM" MỨC 5

✅ Có video GDSK
✅ Có QR code theo bệnh lý
✅ NB trả lời đúng khi đoàn hỏi
✅ Hồ sơ chăm sóc ghi đầy đủ GDSK
✅ Có audit – KPI – cải tiến
✅ Có khảo sát hiểu biết NB
✅ Có tài liệu trực quan đa ngôn ngữ

11. NHỮNG LỖI CHỈ ĐẠT MỨC 3–4

❌ Chỉ phát tờ rơi
❌ Không lượng giá hiểu biết NB

❌ Không ghi hồ sơ
❌ Không audit GDSK
❌ Tư vấn hình thức
❌ NB không nhớ được hướng dẫn
❌ Không có cải tiến

12. CÔNG THỨC NGẮN GỌN ĐẠT MỨC 5 C6.2

- **Có hệ thống GDSK**
- **Điều dưỡng tư vấn thực chất**
- **NB hiểu và hợp tác**
- **Có audit – KPI**
- **Có cải tiến liên tục**
- **Ứng dụng CNTT**

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho tiêu chí C6.2

1. Quyết định ban hành chương trình GDSK.
2. Quy định giáo dục sức khỏe.
3. SOP tư vấn – hướng dẫn người bệnh.
4. Quy định ghi nhận GDSK trong hồ sơ.
5. Phân công trách nhiệm điều dưỡng.
6. Phiếu tư vấn GDSK.
7. Checklist hướng dẫn người bệnh.
8. Phiếu đánh giá hiểu biết người bệnh.
9. Kế hoạch GDSK hằng năm.
10. Bộ tài liệu/tờ rơi GDSK theo chuyên khoa.
11. Phiếu audit GDSK.
12. Báo cáo KPI tháng/quý.
13. Hồ sơ đào tạo nhân viên về GDSK.
14. Hình ảnh minh chứng hoạt động truyền thông – tư vấn cho người bệnh.